

気管内吸引

気管吸引は、侵襲的医療行為であり、その実施により患者の状態が変化することがある。気管吸引実施に際しては、安全を考慮し、病状の悪化を未然に防ぐこと、また、最小限にとどめることが求められる。

①気管吸引の適応：以下の所見で気管内に分泌物があると評価された場合

- 1) 努力性呼吸が強くなっている(呼吸数増加、浅速呼吸、陥没呼吸、補助筋活動の増加、呼気延長等)
- 2) チューブ内に分泌物が見える
- 3) 気管分泌物の存在を示すと考えられる副雑音の聴取(ラ音や喘鳴)
- 4) SpO₂の低下
- 5) 誤嚥した場合
- 6) 人工呼吸器装着時
 - ① 気道内圧の上昇
 - ② 換気量の低下
 - ③ バッキング(咳嗽反射が誘発されて咳き込んだ状態) 等

②吸引の実際 **パルスオキシメーターを装着し実施する**

自発呼吸のある患者は、吸気時にタイミングを合わせてチューブを挿入する
挿入の途中では吸引圧をかけない

吸引圧

**-20kPa(-150mmHg)
を超えない**

時間

1回の吸引操作は10秒以内

1回の挿入開始から
終了までの時間は
20秒以内
人工呼吸器装着患者はサクション
サポートを使用する

長さ

気管分岐部に当たらない長さ

- ① **気管切開部からは
12～15cm**
- ② **鼻や口からは
20～24cm**

★吸引チューブの長さは 50cm

③吸引による 合併症

低酸素血症
血圧異常

高炭酸ガス血症
不整脈 頻脈

気管粘膜の損傷
徐脈

出血 感染

- ・ 吸引後は、症状と合併症の出現がないかアセスメントを行う。
- ・ 吸引操作中に上記合併症を認めたり、何らかの異常を感じたら速やかに操作をやめ、アセスメントする。
- ・ 低酸素血症や不整脈などの循環不全が見られる場合は、酸素投与を行い、すぐに人を呼び対処する。